

CAPÍTULO 9.4

Anemia por Enfermedades Crónicas

PERFIL EUNACOM 1.071.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Anemia por Enfermedades Crónicas (Anemia de la Inflamación)

Segunda **Anemia: Generalidades**|anemia más frecuente después de la ferropénica.

Mecanismo

- La inflamación crónica altera el metabolismo del hierro:
- ↑ **Hepcidina** → secuestra el hierro en los macrófagos → hierro atrapado, no disponible
- Resultado: anemia a pesar de que los depósitos de hierro son normales o altos

Diagnóstico

- Hemograma:** anemia normocítica normocrómica ("normonormo")
- Perfil de hierro:**
 - Ferritina ↑ (reactante de fase aguda positivo)
 - Transferrina/TIBC ↓ (reactante de fase aguda negativo)
 - Saturación variable

Clínica

- Habitualmente **leve a moderada**
- Los síntomas son de la **enfermedad de base**, no de la anemia
- Debe buscarse siempre la causa subyacente

Causas comunes

- Artritis Reumatoide: Clínica y Diagnóstico**|Artritis reumatoide, LES, otras enfermedades autoinmunes
- Tuberculosis**, infecciones crónicas
- Neoplasias
- Insuficiencia renal crónica** (↓ EPO)

Tratamiento

- Tratar la enfermedad de base** → la anemia mejora al controlar la inflamación

- Si hay insuficiencia renal: **eritropoyetina (EPO)** + hierro EV
- No se trata con hierro oral (los depósitos no están bajos — es un problema de utilización)

EUNACOM CRITERIOS

Anemia normonormo + ferritina alta + causa crónica = buscar la enfermedad de base. No dar hierro empírico.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 54 años con Artritis Reumatoide activa de larga data presenta anemia moderada (Hb 10.1 g/dL, VCM 82 fL). Perfil de hierro: Ferritina 380 ng/mL (elevada), Sideremia 35 mcg/dL (baja), TIBC 210 mcg/dL (baja), IST 16%."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Anemia por Enfermedades Crónicas / Inflamación: causada por la elevación de Hepcidina inducida por citoquinas inflamatorias (IL-6), lo que bloquea la salida de hierro desde los macrófagos hacia el plasma. Caracterizada por Ferritina normal o alta (reactante de fase aguda) con TIBC disminuida. Tratamiento: optimizar el control de la enfermedad inflamatoria de base (no responde a hierro oral).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La anemia por enfermedades crónicas es la segunda más frecuente después de la ferropénica
- También se llama anemia de la inflamación
- Suele ser asintomática porque es leve a moderada
- Es una anemia normocítica normocrómica (normo-normo)
- Perfil de hierro: ferritina elevada (reactante fase aguda) y transferrina baja (reactante fase aguda negativo)
- El tratamiento es buscar y tratar la causa subyacente
- Obliga a descartar enfermedades graves como artritis reumatoide, lupus, tuberculosis, vasculitis

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ANEMIA POR ENFERMEDADES CRÓNICAS)

PREGUNTA 1

Paciente de 55 años con anemia normocítica normocrómica, ferritina de 380 ng/mL y transferrina baja. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A) Iniciar suplementación con hierro oral
- B) Transfundir concentrado de glóbulos rojos
- C) Buscar la causa inflamatoria subyacente
- D) Solicitar biopsia de médula ósea
- E) Iniciar eritropoyetina subcutánea

PREGUNTA 2

¿Cuál es la característica clínica más frecuente de la anemia por enfermedades crónicas?

- A) Disnea de reposo
- B) Ictericia
- C) Generalmente es asintomática
- D) Petequias y equimosis
- E) Esplenomegalia

PREGUNTA 3

¿Cuál de los siguientes patrones del perfil de hierro es compatible con anemia por enfermedades crónicas?

- A) Ferritina baja, transferrina alta, saturación baja
- B) Ferritina elevada, transferrina baja
- C) Ferritina muy elevada, saturación muy elevada
- D) Ferritina normal, transferrina normal
- E) Ferritina baja, transferrina baja

RESUMEN: ANEMIA POR ENFERMEDADES CRÓNICAS

Esta clase aborda la anemia por enfermedades crónicas, la segunda anemia en frecuencia después de la ferropénica. También se conoce como anemia de la inflamación, ya que su causa es la inflamación crónica. Su clínica suele ser asintomática porque generalmente es leve a moderada. Los síntomas, cuando existen, son de la enfermedad de base y no de la anemia en particular. El diagnóstico se realiza con hemograma (anemia normocítica normocrómica) más perfil de hierro (ferritina elevada como reactante de fase aguda positivo, transferrina baja como reactante de fase aguda negativo). El tratamiento consiste en buscar y tratar la causa subyacente, que puede ser una enfermedad potencialmente grave como artritis reumatoide, lupus, tuberculosis, vasculitis, entre otras. El hallazgo de una anemia normo-normo con perfil de hierro compatible obliga a buscar esta causa subyacente.